



Faculté de Médecine - Université Constantine3
Enseignement 3^{ème} année Médecine
Année universitaire 2024/2025



Les syndromes pleuraux

Dr N. BOULEKROUNE
Maître assistant en Médecine Interne
Faculté de Médecine
Université Constantine 3

16/02/2025

Objectifs pédagogiques

- I. Définir les syndromes pleuraux.
- II. Différencier entre le syndrome pleural liquidien et aérien.

Introduction

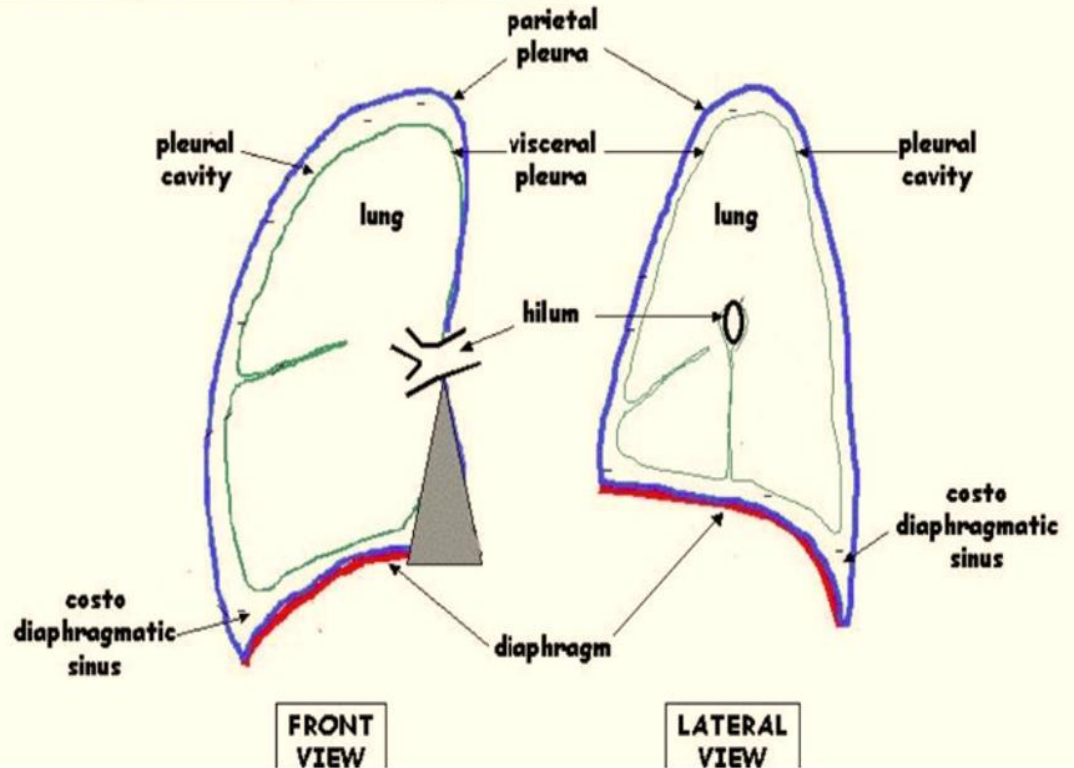
- Définition d'un syndrome : ensemble de signes cliniques et/ou paracliniques regroupant plusieurs étiologies.
- Classification des syndromes respiratoires : elle est anatomique (bronches, poumons, plèvres, médiastin et parois).
- Syndrome pleural : se définit par un ensemble de signes cliniques et paracliniques traduisant la présence anormale de liquide, d'air, ou de tissu dans tout ou partie de la cavité pleurale.

PLÈVRE

Espace virtuel

Le liquide pleural
(production de 5-20 cc/j)
permet le glissement des
2 feuillets l'un contre
l'autre et produit par la
plèvre pariétale

Anatomy of the pleural space



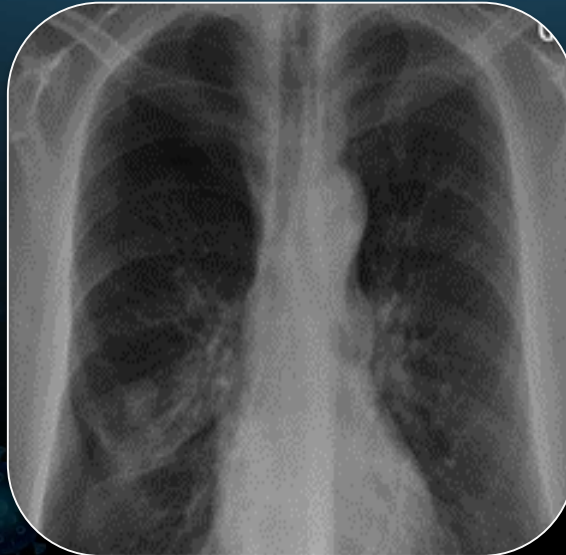
Dans les situations pathologiques

La cavité pleurale n'est plus virtuelle

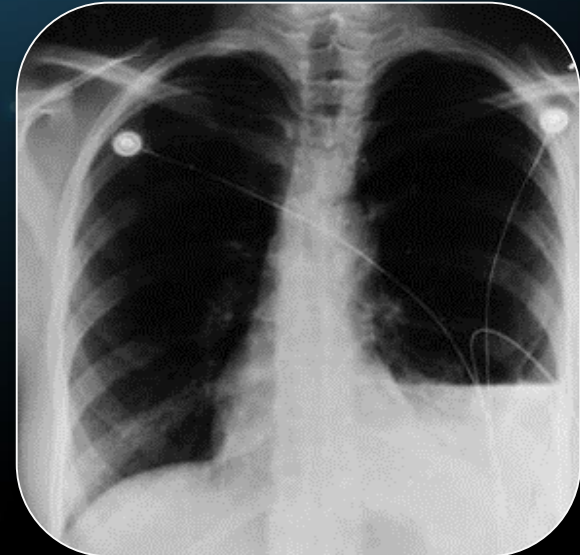
Pleurésie



Pneumothorax



Hydro-pneumothorax





01

**Le syndrome
d'épanchement pleural
liquidien ou pleurésie**

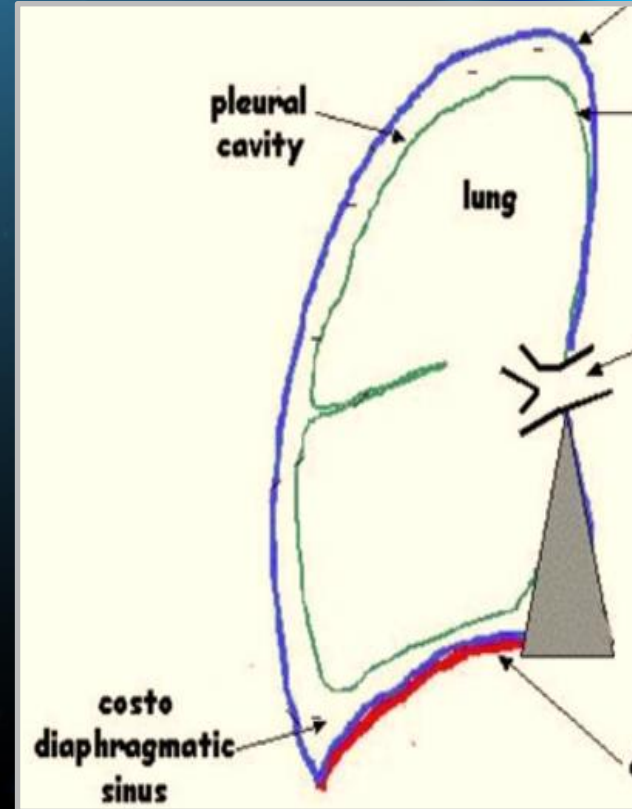
Le syndrome d'épanchement pleural liquidien ou pleurésie

Est une situation clinique **fréquente**.

En rapport avec une accumulation de liquide entre les 2 feuillets pleuraux.

Provoquer par un déséquilibre entre la formation du liquide pleural et la capacité des feuillets pleuraux à résorber ce liquide.

La symptomatologie clinique varie en fonction de l'abondance de l'épanchement.



Diagnostic clinique

Circonstances de découverte

Fortuite

Douleur basithoracique

Dyspnée

Toux sèche

Signes généraux
(variables) :

Fièvre, sueurs, altération
de l'état général



Examen physique

Diminution de l'ampliation
thoracique homolatérale

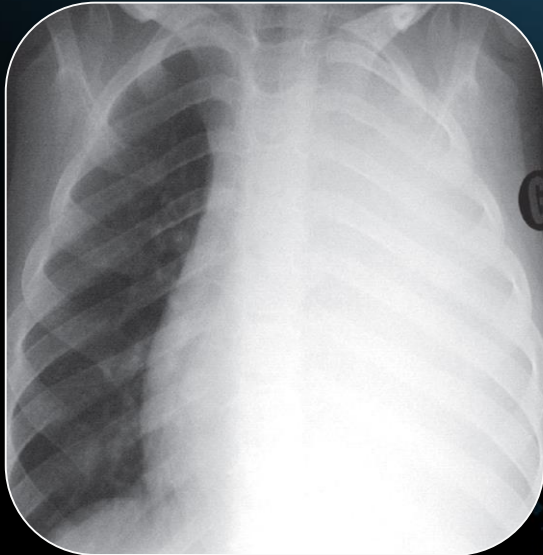
Abolition des
vibrations vocales

Matité franche,
hydrique, de bois

Abolition ou diminution
de murmure vésiculaire

La présentation clinique et radiologique peut varier en fonction de l'abondance de l'épanchement

**Pleurésie de
grande abondance**



**Pleurésie de
moyenne abondance**



**Pleurésie de
faible abondance**



Pleurésie de moyenne abondance

Forme la plus fréquente et la plus typique

A. Signes fonctionnelles

01

Douleur

Le signe le plus fréquent
À type de point de coté

Survenant à :

- l'inspiration profonde
- la toux
- aux changements de position

02

Toux

Sèche

Déclenchée par les
changements de
position

03

Dyspnée

Type de tachypnée
superficielle

Pleurésie de moyenne abondance

B. Signes physiques

Inspection

Diminution de l'ampliation thoracique

Dilatation de l'hémithorax atteint

Élargissement des espaces intercostaux



Pleurésie de moyenne abondance

B. Signes physiques

Palpation

Abolition des vibrations vocales



Pleurésie de moyenne abondance

B. Signes physiques

Percussion

Le temps fondamental de l'examen ++

Matité franche de bois

La limite supérieure à la forme d'une courbe parabolique à sommet axillaire



Pleurésie de moyenne abondance

B. Signes physiques

Auscultation

Abolition du murmure vésiculaire

Souffle pleurétique

{ inconstant

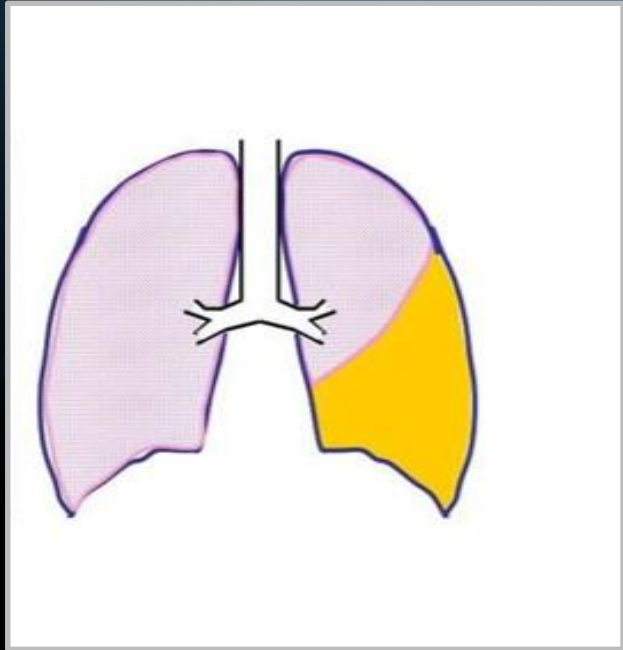
{ doux, lointain, expiratoire

{ étendu à la limite supérieure de la matité



Pleurésie de moyenne abondance

Triade de Trousseau



01

Abolition des vibrations vocales

02

Matité franche de bois

03

Abolition du murmure vésiculaire

Radiographie du thorax

Indispensable devant toute suspicion de pleurésie.

L'épanchement pleural est facilement identifiable à partir de 150 cc sur les clichés pulmonaires de face.

S'accumule dans la partie déclive du thorax.



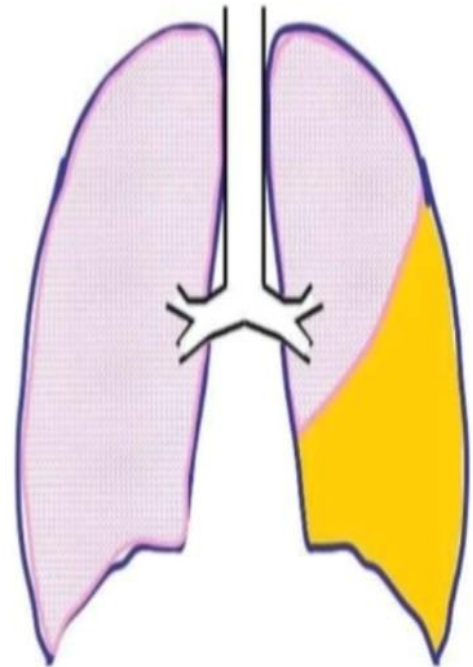
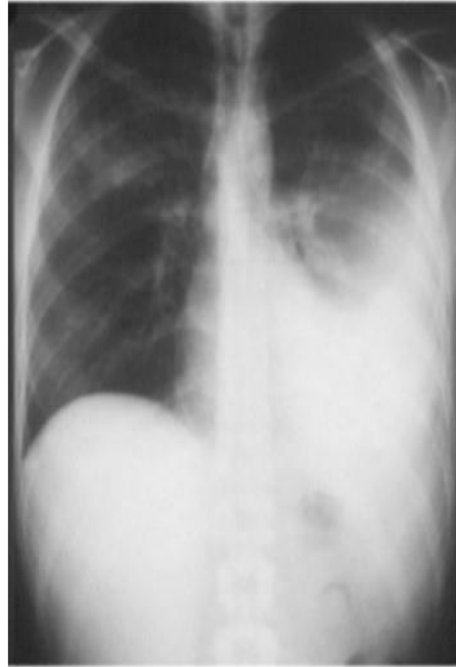
Pleurésie de moyenne abondance

Téléthorax de face

Opacité dense, homogène
Non systématisée
Déclive
Effaçant le diaphragme.

Courbe de **DAMOISEAU**
radiologique : à limite
supérieure concave
(concavité supéro-interne).

Absence de bronchogramme.



Pleurésie de moyenne abondance

Télethorax de face

Opacité dense, homogène

Non systématisée

Déclive

Effaçant le diaphragme.

Courbe de **DAMOISEAU**
radiologique : à limite
supérieure concave
(concavité supéro-interne).

Absence de bronchogramme.



Pleurésie de moyenne abondance

Téléthorax de face

Opacité dense, homogène

Non systématisée

Déclive

Effaçant le diaphragme.

Courbe de **DAMOISEAU**
radiologique : à limite
supérieure concave
(concavité supéro-interne).

Absence de bronchogramme.



Pleurésie de grande abondance

B. Signes physiques

Inspection

Diminution de l'ampliation thoracique

Distension nette de l'hémithorax atteint

Élargissement marquée des espaces intercostaux



Pleurésie de grande abondance

B. Signes physiques

Palpation

Abolition des vibrations vocales



Pleurésie de grande abondance

B. Signes physiques

Percussion

Le temps fondamental de l'examen ++

Matité franche de bois
Occupant tout un hémithorax

La limite supérieure horizontale atteint ou dépasse l'épine de l'omoplate en arrière et la clavicule en avant



Pleurésie de grande abondance

B. Signes physiques

Auscultation

Abolition du murmure vésiculaire de tout un hémithorax

Souffle pleurétique : n'est jamais retrouvé



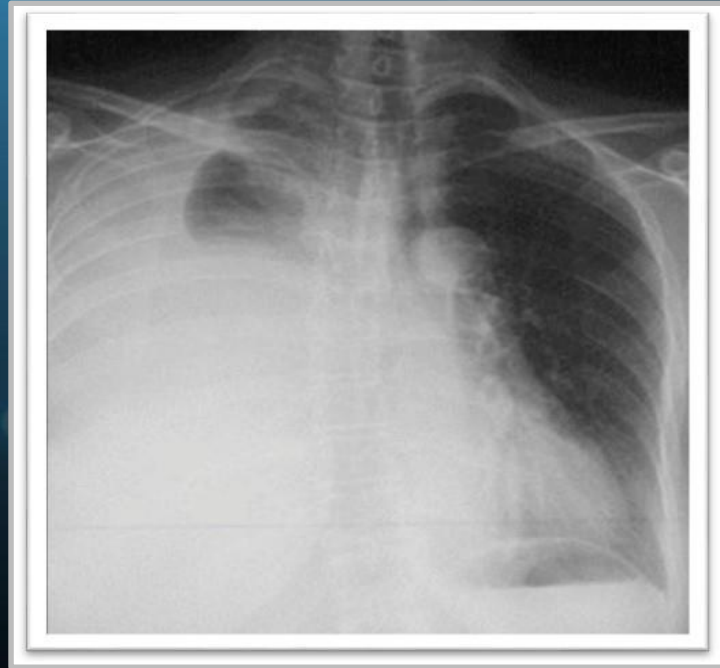
Pleurésie de grande abondance

Pleurésie massive.

Opacité très dense, homogène refoulant le médiastin.

Avec effacement de la coupole diaphragmatique.

Pas de bronchogramme aérien.



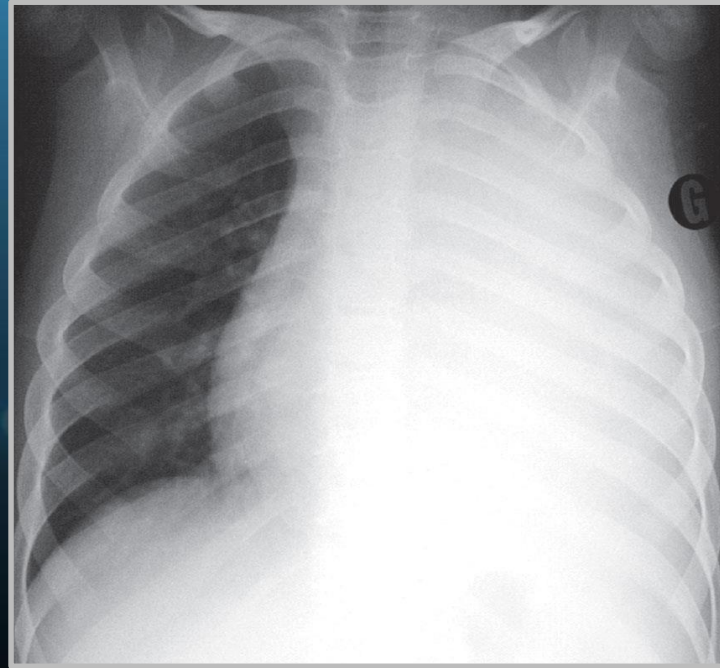
Pleurésie de grande abondance

Pleurésie massive.

Opacité très dense, homogène refoulant le médiastin.

Avec effacement de la coupole diaphragmatique.

Pas de bronchogramme aérien.



Pleurésie de grande abondance

Pleurésie massive.

Opacité très dense, homogène refoulant le médiastin.

Avec effacement de la coupole diaphragmatique.

Pas de bronchogramme aérien.



Pleurésie de faible abondance

La symptomatologie clinique est **pauvre**.

Signes physiques

Percussion : submatité de la base.

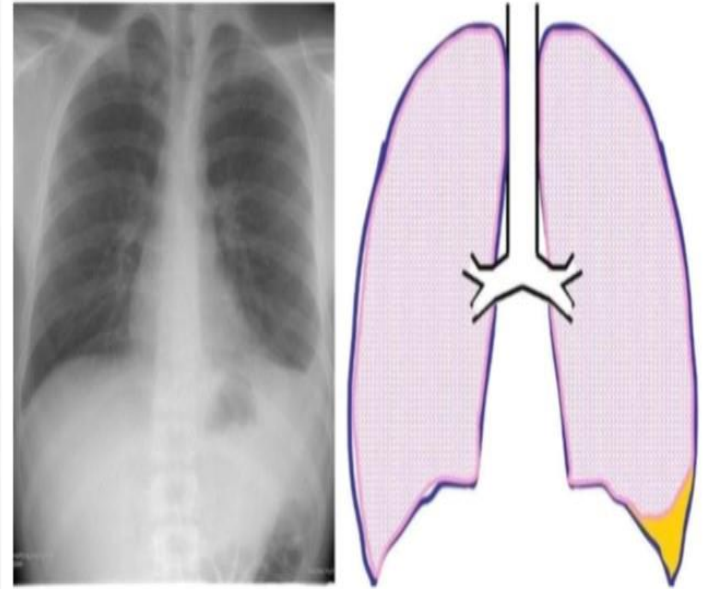
L'auscultation :

[diminution du murmure vésiculaire
frottements pleuraux localisés : inconstants.

Télethorax de face

Emoussement du cul de sac.

Intérêt du cliché de profil.



Pleurésie de faible abondance

La symptomatologie clinique est **pauvre**.

Signes physiques

Percussion : submatité de la base.

L'auscultation :

[diminution du murmure vésiculaire
frottements pleuraux localisés : inconstants.

Télethorax de face

Emoussement du cul de sac.

Intérêt du cliché de profil.



Ponction pleurale

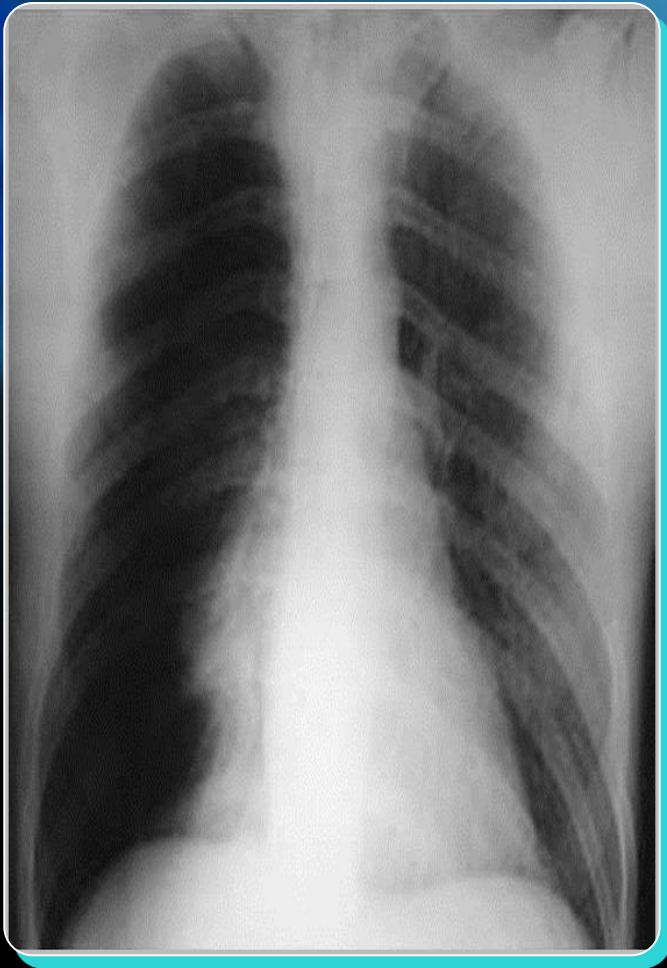
Dans tous les cas, le diagnostic clinique et radiologique devra _____ être confirmé par une ponction pleurale.

Respecter les contre-indications_____.

La ponction pleurale permet de :

- confirmer la pleurésie
- fait la distinction entre exsudat _____ et transsudat
- assurer un diagnostic présomptif ou définitif.





02

**Le syndrome
d'épanchement pleural
aérien ou pneumothorax**

Pneumothorax

Défini par la présence d'air dans la cavité pleurale par rupture de la plèvre viscérale.

Il est spontané ou secondaire.

La forme idiopathique est la plus fréquente et touche avec prédilection les sujets masculins longilignes entre 20 et 30 ans.

Pneumothorax

A. Signes fonctionnelles

01

Douleur

- À type de point de coté
- Parfois en coup de poignard
- Aggravé par l'inspiration profonde ou la toux

02

Toux

- Sèche
- Déclenchée par les changements de position

03

Dyspnée et angoisse

Pneumothorax

B. Signes physiques

Inspection

Diminution de l'ampliation thoracique

Ou immobilité de l'hémithorax atteint

Élargissement des espaces intercostaux



Pneumothorax

B. Signes physiques

Palpation

Abolition des vibrations vocales



Pneumothorax

B. Signes physiques

Percussion

Le temps fondamental de l'examen ++

Tympanisme Ou augmentation de la sonorité normale du côté atteint (comparaison avec le côté sain)



Pneumothorax

B. Signes physiques

Auscultation

Abolition du murmure vésiculaire



Pneumothorax

	Triade de GAILLARD	Triade de TROUSSEAU
Palpation	Abolition des vibrations vocales	Abolition des vibrations vocales
Percussion ++	Tympanisme ou hypersonorité	Matité franche de bois
Auscultation	Abolition du murmure vésiculaire	Abolition du murmure vésiculaire

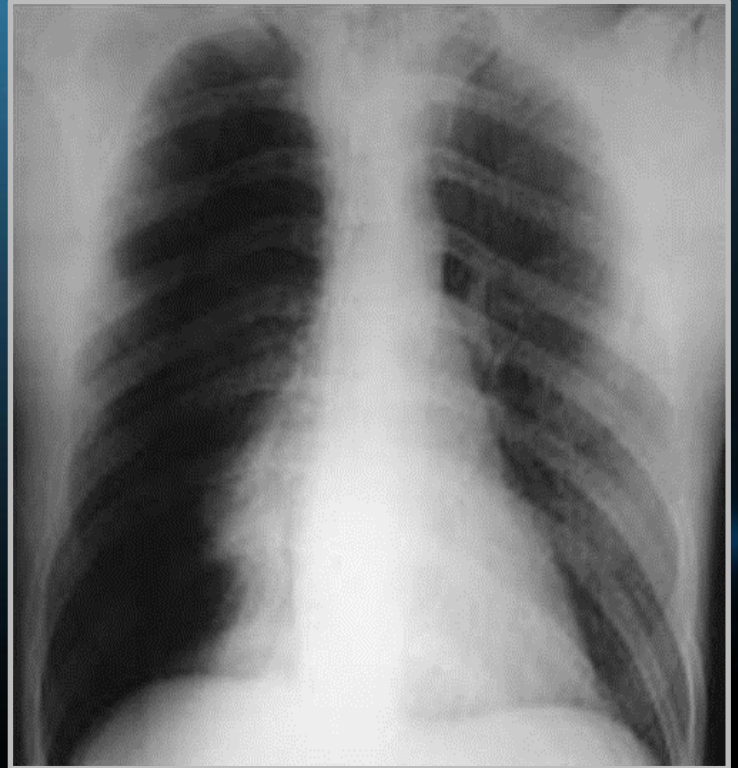
Pneumothorax

Hyperclarté d'un hémithorax.

Dépourvue de trame vasculaire.

Séparée du parenchyme pulmonaire
sous jacent par un **fin liseré opaque**
correspondant à la plèvre viscérale.

Le moignon pulmonaire rétracté dans
la région hilare.



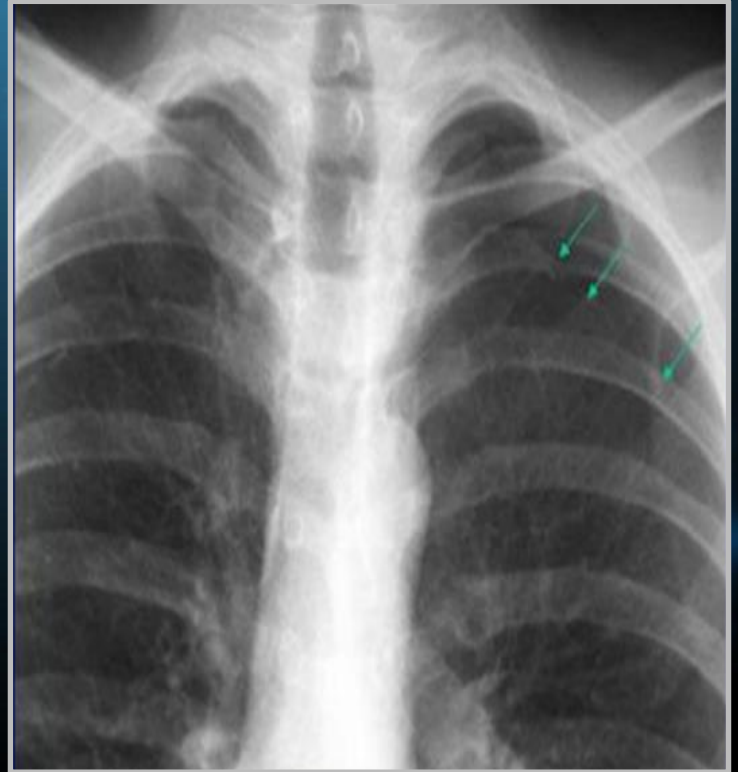
Pneumothorax

Hyperclarté d'un hémithorax.

Dépourvue de trame vasculaire.

Séparée du parenchyme pulmonaire
sous jacent par un **fin liseré opaque**
correspondant à la plèvre viscérale.

Le moignon pulmonaire rétracté dans
la région hilare.



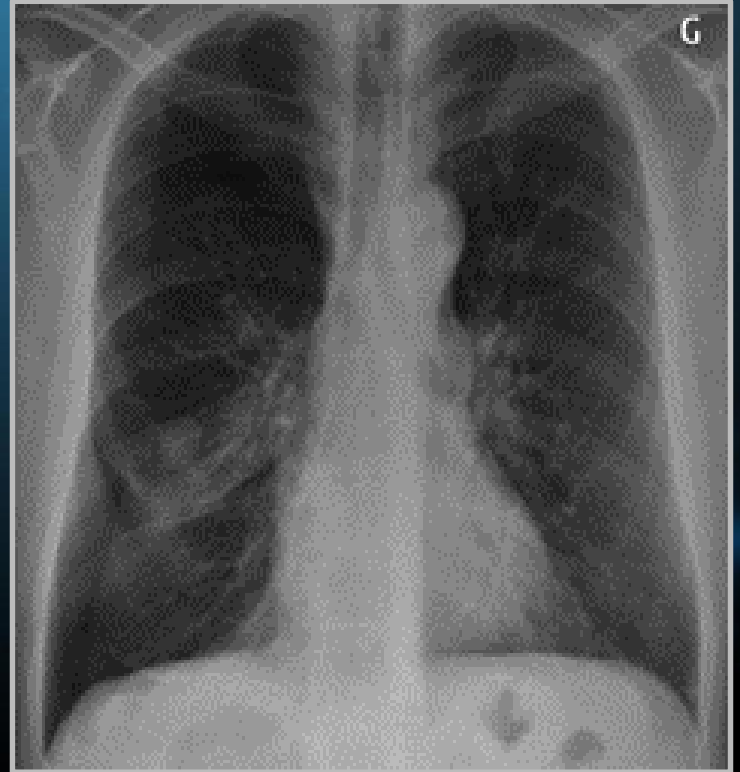
Pneumothorax

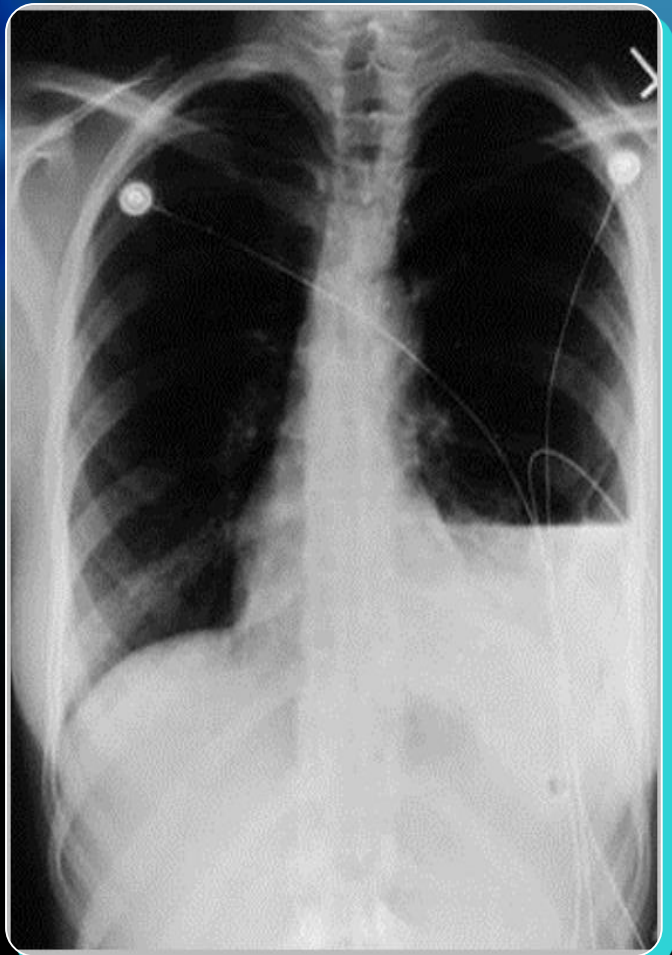
Hyperclarté d'un hémithorax.

Dépourvue de trame vasculaire.

Séparée du parenchyme pulmonaire
sous jacent par un **fin liseré opaque**
correspondant à la plèvre viscérale.

Le moignon pulmonaire rétracté dans
la région hilare.





04

**Le syndrome
d'épanchement pleural
mixte aéro-liquidien**

Epanchement pleural mixte

Il réalise une complication fréquente du pneumothorax.

Selon la qualité du liquide, il s'agira soit :

- D'un hydro-pneumothorax (liquide clair)
- D'un pyo-pneumothorax (liquide purulent)
- D'un hémopneumothorax (liquide hématique).

Signes d'épanchement liquidien à la base et d'épanchement aérique au sommet.

Epanchement pleural mixte

Signes physiques

Inspection

Hémithorax immobile et distendu

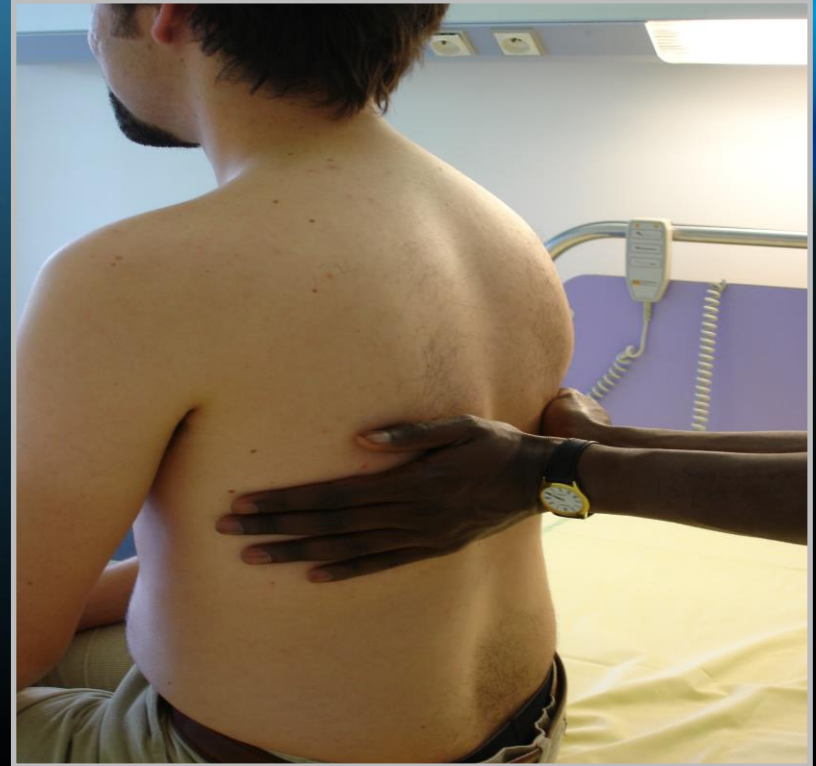


Epanchement pleural mixte

Signes physiques

Palpation

Abolition des vibrations vocales
sur toute l'étendue de l'hémithorax



Epanchement pleural mixte

Signes physiques

Percussion

Le temps fondamental de l'examen ++

Matité franche de bois de la partie inférieure de l'hémithorax à limite supérieure horizontale

Surmontée d'un tympanisme ou d'une hypersonorité du côté atteint (comparaison avec le côté sain)



Epanchement pleural mixte

Signes physiques

Auscultation

Abolition du murmure vésiculaire sur toute la hauteur de l'hémithorax



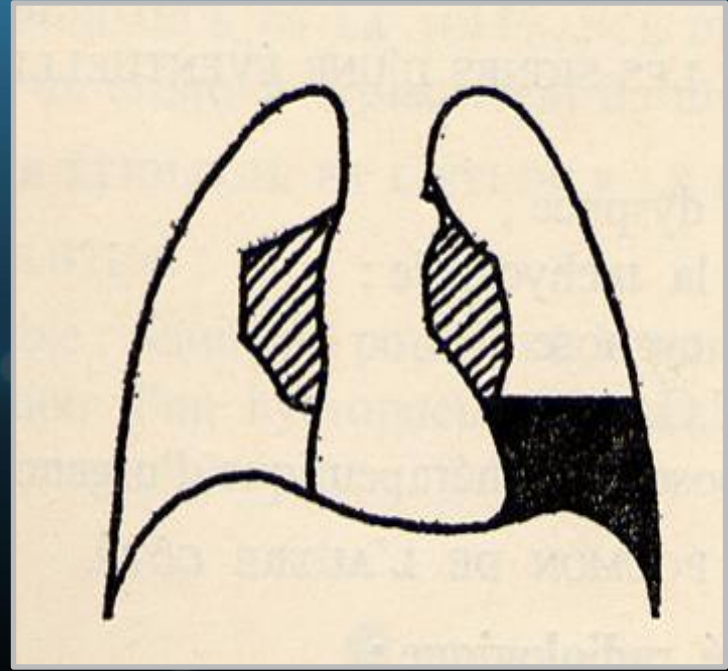
Epanchement pleural mixte

Une opacité franche, homogène de la base du poumon.

Comblant le sinus costo-diaphragmatique.

A limite supérieure **horizontale**.

Surmonte d'une hyperclarté.



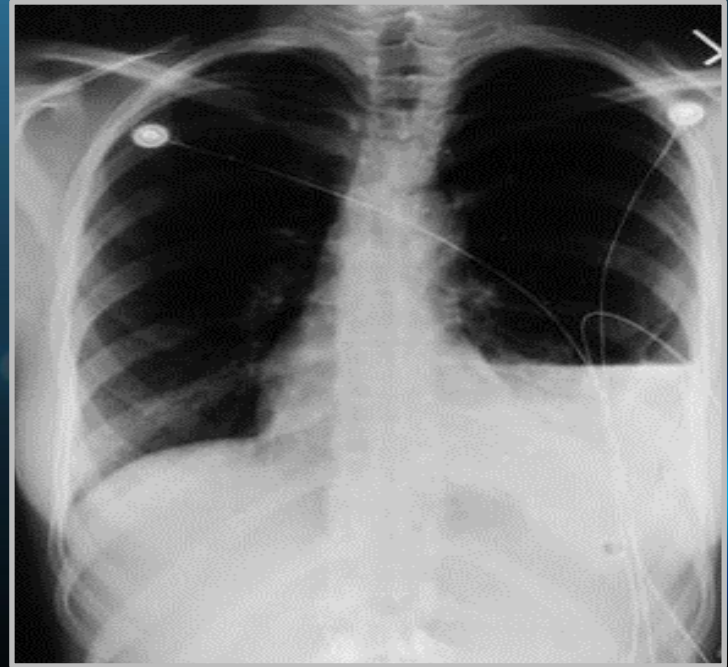
Epanchement pleural mixte

Une opacité franche, homogène de la base du poumon.

Comblant le sinus costo-diaphragmatique.

A limite supérieure **horizontale**.

Surmonte d'une hyperclarté.



Thanks

